

Manual Oposiciones

TCAE SERMAS



Te preparamos **HOY**
para lo que el 
te pedirá **MAÑANA.**



GUÍA DE ESTUDIO PARA LA OPOSICIÓN DE TCAE SERMAS

La preparación para la oposición de TCAE SERMAS requiere una planificación cuidadosa y una metodología de estudio efectiva. A continuación, te presento una guía detallada basada en los consejos proporcionados para ayudarte a dominar el temario de manera eficiente.

1. Planificación del Estudio

- **Estructura del Temario:** Divide el temario en bloques y asigna un tiempo específico para cada uno, de acuerdo con la dificultad o extensión de los temas. Asegúrate de que la distribución del tiempo sea equilibrada para cubrir todo el contenido antes del examen.
- **Calendario de Estudio:** Crea un calendario semanal o mensual para organizar el estudio. Asegúrate de incluir días de repaso y descansos. Es esencial comenzar cuanto antes, así tendrás margen para imprevistos.
- **Objetivos Diarios y Semanales:** Establece metas claras para cada día y semana, como terminar un número determinado de temas o apartados. Cumplir estos objetivos te ayudará a mantener un ritmo constante.

2. Uso de Herramientas de Estudio

- **Esquemas y Resúmenes:** Realiza esquemas o resúmenes de cada tema para visualizar mejor la información. Los mapas conceptuales también pueden ayudarte a conectar ideas clave y mejorar la comprensión.
- **Subrayado:** Usa el subrayado como técnica para destacar las partes más importantes. Esto te ayudará a identificar rápidamente las ideas clave durante el repaso.
- **Memorización Activa:** Repite en voz alta o escribe de memoria los conceptos que te resulten más complicados. Esta técnica activa tu memoria y favorece el aprendizaje a largo plazo.

3. Resolución de Dudas

- **Consulta de Dudas:** Es importante no dejar dudas sin resolver. Si estás asistiendo a una academia, consulta con tus profesores o compañeros cualquier aspecto que no comprendas. Si estudias de manera autónoma, busca fuentes confiables para aclarar tus dudas.
- **Foros y Grupos de Estudio:** Participar en foros o grupos de estudio te permitirá intercambiar opiniones y resolver dudas de manera colaborativa.

4. Repasos Constantes

- **Revisión Periódica:** Es fundamental repasar todo lo estudiado con regularidad. Organiza sesiones de repaso semanales para reforzar lo aprendido. Cuanto más fresco tengas el material, más seguro te sentirás en el examen.
- **Simulacros de Examen:** Realiza simulacros de examen o tests de autoevaluación para medir tu progreso. Esto te ayudará a identificar los puntos débiles y mejorarlos antes de la prueba.

5. Descanso y Cuidado Personal

- **Pausas Frecuentes:** No estudies de manera ininterrumpida. Después de cada 45-50 minutos de estudio, toma un descanso de 5-10 minutos. Este método, conocido como Pomodoro, te ayudará a mantener la concentración y evitar el agotamiento.
- **Alimentación y Sueño:** Mantén una dieta equilibrada y duerme las horas necesarias para mantener tu mente alerta. La falta de sueño y una mala alimentación pueden afectar negativamente tu capacidad de concentración.
- **Actividad Física:** Incorpora ejercicio físico ligero en tu rutina diaria para liberar tensiones y mantener tu energía.

6. Consejos Finales

- **Comienza lo Antes Posible:** El tiempo es tu mejor aliado. Cuanto antes comiences con tu preparación, más seguro te sentirás y mejor podrás dominar el temario.
- **Constancia y Concentración:** Mantente constante en tus estudios, evitando distracciones y manteniendo un ambiente adecuado de estudio.

Este documento fue descargado por Maria del Pilar Marquina desde ucademy.com
Su distribución no está permitida y es solo para uso de alumnos registrados.
29/12/2025

ÍNDICE

TEMA 10

1. Actividades del tcae en atención primaria y hospitalaria	2
FUNCIONES DEL TCAE EN ATENCIÓN PRIMARIA	2
FUNCIONES DEL TCAE EN ATENCIÓN HOSPITALARIA	3
MATERIAL COMPLEMENTARIO	7
2. Coordinación entre niveles asistenciales	10
DIRECCIÓN POR OBJETIVOS	11
EL CONTRATO PROGRAMA	11
PLANES DE COLABORACIÓN LINTERNIVELES	13
3. Concepto de cuidados, necesidades básicas y autocuidados	15
MODELOS DE ENFERMERÍA	15
RESUMEN Y CONSIDERACIONES GENERALES	18
4. El hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado	20
IMPACTO DE LA HOSPITALIZACIÓN EN EL PACIENTE	20
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN	21
GUÍAS Y PROTOCOLOS RELACIONADOS (SERMAS)	25

Este documento fue descargado por Maria del Pilar Marquina desde Ucademy.com
 Su distribución no está permitida y es solo para uso de alumnos registrados

TEMA 10

Este documento fue descargado por alumno@ucademy.com
Su distribución no está permitida y es solo para uso de alumnos registrados.

1. ACTIVIDADES DEL TCAE EN ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA

INTRODUCCIÓN GENERAL

El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), regulado por el Real Decreto 546/1995, es un profesional del área sanitaria que presta cuidados auxiliares al paciente y colabora con el equipo de enfermería en centros sanitarios y sociosanitarios. Su actuación está centrada en la atención directa a las personas, en el marco del equipo de salud.

En el contexto del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), el TCAE desarrolla funciones tanto en atención primaria como en el ámbito hospitalario, adaptando sus actividades a los distintos niveles asistenciales y necesidades del paciente.

OBJETIVO

- Identificar y diferenciar las funciones del TCAE en atención primaria y en atención hospitalaria.
- Relacionar esas funciones con el marco legal vigente (RD 546/1995).

MARCO NORMATIVO: REAL DECRETO 546/1995

- Establece las enseñanzas mínimas del título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
- Define sus competencias generales: cuidados auxiliares al paciente, higiene, movilización, administración de alimentos, apoyo psicológico, colaboración en técnicas sanitarias, etc.
- Subraya el trabajo interdisciplinar y el respeto a la confidencialidad y dignidad del paciente.

FUNCIONES DEL TCAE EN ATENCIÓN PRIMARIA

En atención primaria, el TCAE se enfoca en el **seguimiento de pacientes crónicos**, **promoción de la salud** y **apoyo al equipo** en consultas. La relación con el paciente suele ser más cercana y prolongada. !!

- Participar en la elaboración del **diagnóstico de Salud de la zona**, planificación, organización y evaluación de los programas como apoyo a las tareas realizadas por el resto del personal sanitario.
- Ayudar en las **labores de promoción y prevención de Salud** (a través de lo que denominamos **educación para la salud**), así como en la **atención** a los enfermos y en la **rehabilitación** de las secuelas dejadas por la enfermedad.
- **Colaborar en las pruebas diagnósticas** y en la aplicación de **tratamientos**, como **apoyo al personal de enfermería**.
- Realizar la **higiene, alimentación, vestir y desvestir** al enfermo, etc., si ello fuera necesario.
- Contribuir a **mejorar la calidad** del sistema de Salud, desde su posición como profesional de la Salud.

FUNCIONES DEL TCAE EN ATENCIÓN HOSPITALARIA

En hospitales, el TCAE actúa como **colaborador directo del personal de enfermería**, especialmente en unidades de hospitalización, quirófano, urgencias, UCI, etc. Su trabajo **requiere conocimiento técnico, empatía y habilidades organizativas**. !!

NOTA

Para diferenciar las competencias de los TCAE en el ámbito de la Atención Especializada, vamos a basarnos en el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Ésta antigua normativa fue derogada por el actual Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003, de 16 de diciembre). No obstante, en su disposición transitoria sexta da validez a las antiguas funciones mientras no se desarrollen normas nuevas, por ello vamos a describir las actividades de los auxiliares de enfermería según el antiguo Estatuto.

En general:

Corresponden a las Auxiliares de Enfermería ejercer, en general, los **servicios complementarios de la asistencia sanitaria** en aquellos aspectos **que no sean de la competencia del Personal Auxiliar Sanitario Titulado**. A tales efectos, se **atenderán a las instrucciones que reciban del citado personal** que tenga atribuida la responsabilidad en la esfera de su competencia del Departamento Servicio donde actúen las interesadas, y, en todo caso, **dependerán de la Jefatura de Enfermería y de la Dirección del Centro**. !!

Igualmente cumplirán aquellas otras funciones que se señalen en los Reglamentos de Instituciones Sanitarias y las instrucciones propias de cada Centro, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en los Servicios de Enfermería serán:

1. Hacer las camas de los enfermos, excepto cuando por su estado le corresponda al DUE, ayudando a los mismos en este caso.
2. Realizar el aseo y limpieza de los enfermos, ayudando al Personal Auxiliar Sanitario Titulado, cuando la situación del paciente lo requiera.
3. Llevar las cuñas a los enfermos y retirarlas, teniendo cuidado de su limpieza.
4. Realizar la limpieza de los carros de cura y de su material.
5. La recepción de los carros de comida y la distribución de la misma.
6. Servir las comidas a los enfermos, atendiendo a la colocación y retirada de bandejas, cubiertos y vajilla; entendiéndose que dicha retirada se efectuará por el personal al que corresponda desde la puerta de la habitación de los enfermos.
7. Dar la comida a los enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos, salvo en aquellos casos que requieran cuidados especiales.
8. Clasificar y ordenar la lencería de planta a efectos de reposición de ropa y vestuario, relacionándose con los servicios de lavadero y planta, presenciando la clasificación y recuento de estas, que se realizarán por el personal de lavadero.
9. Por indicación del Personal Auxiliar Sanitario Titulado colaborarán en la administración de medicamentos por vía oral y rectal, con exclusión de la vía parenteral. Asimismo, podrán aplicar enemas de limpieza, salvo en casos de enfermos graves.
10. Colaborar con el Personal Auxiliar Sanitario Titulado y bajo su supervisión en la recogida de los datos termométricos. Igualmente recogerán los signos que hayan

llamado su atención, que transmitirá a dicho personal, en unión de las espontáneas manifestaciones de los enfermos sobre sus propios síntomas.

11. Colaborar con el Personal Auxiliar Sanitario Titulado en el rasurado de las enfermas.
12. Trasladar, para su cumplimiento por los Celadores, las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores.
13. En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera o Ayudante Técnico Sanitario, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en los Departamentos de Quirófano y Esterilización serán:

1. El cuidado, conservación y reposición de batas, sabanillas, toallas, etc.
2. El arreglo de guantes y confección de apósitos de gasa y otro material.
3. Ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en la preparación del material para su esterilización.
4. La recogida y limpieza del instrumental empleado en las intervenciones quirúrgicas, así como ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en la ordenación de las vitrinas y arsenal.
5. En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y del DUE, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en los Departamentos de Tología serán:

1. Recogida y limpieza del instrumental.
2. Ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en las atenciones a las pacientes y en la limpieza de pul motores, ventosas y demás aparatos.
3. Acompañar a las pacientes y recién nacidos a los servicios y plantas que les sean asignados, atendiéndolos y vigilándolos hasta que estén instalados en donde les corresponda.
4. Vestir y desvestir a las embarazadas, así como el aseo y limpieza.
5. Pasar a las camas a las parturientas, ayudadas por el Personal Auxiliar Sanitario Titulado.
6. Cambiar las camas de las pacientes en los Departamentos de Dilatación, con la ayuda de la Matrona, cuando el estado de ellas lo requiera.
7. Poner y quitar cuñas y limpieza de las mismas.
8. Colaborar con las Matronas en el rasurado de las parturientas y en la aplicación de enemas de limpieza.
9. Cambiar las ropas de las camas y las compresas y ropas de las parturientas con ayuda del Personal Auxiliar Sanitario Titulado, cuando el estado de la paciente lo requiera.
10. En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera o Ayudante Técnico Sanitario, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en los Departamentos de RadioElectrología serán:

1. Ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en las atenciones a los enfermos.
2. Ayudar en la preparación de los chasis radiográficos, así como al revelado, clasificación y distribución de las radiografías y a la preparación de los aparatos de electromedicina.
3. En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y del DUE, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Las funciones de las Auxiliares de Enfermería, en los departamentos de Laboratorio serán las de realizar la limpieza y colaborar con el Personal Auxiliar Sanitario Titulado en la ordenación de la frasería y material utilizado en el trabajo diario y, en general, todas aquellas actividades que, sin tener carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera o Ayudante Técnico Sanitario.

En el Servicio de Admisión de Enfermos, las Auxiliares de Enfermería acompañarán a los enfermos a las plantas y servicios que les sean asignados, siempre que no sean trasladados en camillas, y, en general, realizarán todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera o Ayudante Técnico Sanitario.

En el Departamento de Consultas Externas de las Instituciones cerradas corresponderán a las Auxiliares de Enfermería las misiones de ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en su cometido respecto a aquellos enfermos susceptibles de hospitalización y, en general, realizarán todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera o Ayudante Técnico Sanitario.

Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en la Farmacia serán:

1. Colaborar con el personal Auxiliar Sanitario Titulado o Auxiliar de Farmacia en la ordenación de los preparados y efectos sanitarios.
2. Contribuir al transporte de los preparados y efectos sanitarios siempre que su volumen y su peso no excedan de los límites establecidos en la legislación vigente.
3. Atender a las demás relaciones de la Familia con las plantas de Enfermería y Departamentos y Servicios de la Institución.
4. En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera o Ayudante Técnico Sanitario, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en la Unidad de Rehabilitación serán:

1. El aseo y limpieza de los pacientes.
2. La limpieza y ordenación del material utilizado en la unidad, bajo la supervisión del Personal Auxiliar Sanitario Titulado.
3. Ayudar a dicho personal en la colocación o fijación del paciente en el lugar especial de su tratamiento.
4. Controlar las posturas estáticas de los enfermos, con supervisión del Personal auxiliar Sanitario Titulado.
5. Desvestir y vestir a los pacientes cuando lo requiera su tratamiento.
6. Recoger y reponer las ropas de uso en la Unidad.

7. En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y del DUE, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Las funciones de las Auxiliares de Enfermería en las Instituciones sanitarias abiertas serán:

1. La acogida y orientación personal de los enfermos.
2. La recepción de volantes y documentos para la asistencia de los enfermos.
3. La distribución de los enfermos para la mejor ordenación en el horario de visita.
4. La escritura de libros de registro, volantes, comprobantes e informes.
5. La limpieza de vitrinas, material e instrumental.
6. La preparación de ropas, venda, apósitos y material de curas.
7. Recogida de datos clínicos, limitados exclusivamente a los termométricos y a aquellos signos obtenidos por la inspección no instrumental del paciente, para cuya obtención hayan recibido indicación expresa del DUE, así como orientación del Médico responsable.
8. Recogida de los signos y manifestaciones espontáneas de los pacientes sobre sus síntomas, y limitándose a comunicarlos al Médico o DUE de quien dependan.
9. En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del Médico y del DUE, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

IMPORTANTE

Queda prohibido a las Auxiliares de Enfermería la realización de los cometidos siguientes:

1. Administración de medicamentos por vía parenteral.
2. Escarificaciones, punturas o cualquier otra técnica diagnóstica o preventiva.
3. La aplicación de tratamientos curativos de carácter no medicamentoso.
4. La administración de sustancias medicamentosas o específicas, cuando para ello se requiere instrumental o maniobras cuidadosas.
5. Ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas.
6. Auxiliar directamente al Médico en las consultas externas.
7. En general realizar funciones de la competencia del Personal Auxiliar Sanitario Titulado, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

REAL DECRETO 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas.

COMPETENCIA GENERAL

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como: **miembro de un equipo de enfermería** en los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la **dependencia del diplomado de enfermería** o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.

Capacidades profesionales !

- Interpretar y comprender la información y el lenguaje asociados a los distintos procesos de atención sanitaria relacionados con el ejercicio de su actividad profesional.
- Realizar tareas administrativas y de organización de una consulta, por lo general del sector privado, evaluar las necesidades de productos y materiales fungibles o no, administrando sus existencias en la consulta, dentro de su ámbito de competencias.
- Poseer una visión de conjunto y coordinada de las distintas condiciones sanitarias de los pacientes/clientes, cuidados auxiliares de enfermería a realizar, e instrumental y material utilizado en las distintas consultas, unidades y/o servicios.
- Promover, a su nivel, la humanización de la asistencia sanitaria al paciente/cliente utilizando técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria.
- Realizar las tareas de ayuda e instrumentación en los equipos/gabinetes de salud bucodental.
- Aplicar técnicas hidrotermales básicas, manejando, regulando y secuenciando los equipos e instalaciones correspondientes, observando los procedimientos establecidos y registrando e informando las incidencias y anomalías que se produzcan durante la realización de la terapia.
- Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénicosanitarios en la población.
- Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo las responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados y manteniendo el flujo de información adecuado.
- Valorar, a su nivel, la interrelación de las personas con la salud/enfermedad y sus aspectos preventivos, asistenciales y rehabilitadores.
- Actuar en condiciones de emergencia, transmitiendo con celeridad y serenidad las señales de alarma y aplicando los medios de seguridad establecidos.
- Poseer una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos organizativos, funcionales, sociales y administrativos.
- Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su área laboral.

NOTA

Aunque la ley no diferencia las competencias del TCAE en Atención Primaria u Hospitalaria, establece las funciones de este profesional de una forma más actual. Como hemos visto al principio de este tema podríamos diferenciarlas acorde al tipo de trabajo más habitual que se desarrolla en cada nivel asistencial. Si bien, para diferenciarlas, debemos observar el antiguo Estatuto que se ha desarrollado al principio del tema.

COMPETENCIAS

1. Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad, en las áreas de su competencia.
2. Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.
3. Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental sanitario utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios.
4. Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente, realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria.
5. Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.

UNIDADES DE COMPETENCIA ESPECÍFICAS !!

Punto primero: !!

- 1.1 Citar, recibir y registrar los datos a los pacientes/clientes cumpliendo las normas establecidas en cada consulta
- 1.2 Verificar la existencia del material necesario para la realización de las actividades propias de cada consulta.
- 1.3 Recibir y emitir, en su caso, información verbal y escrita necesaria para la correcta coordinación con otras unidades según las normas establecidas en el centro.
- 1.4 Realizar los presupuestos y facturas de una consulta de asistencia médica u odontológica, según normas y tarifas propias de cada consulta y por acto profesional.

Punto segundo: !!

- 2.1 Lavar, asear y realizar la higiene de los pacientes en función de sus necesidades y del plan de cuidados.
- 2.2 Preparar al paciente para su traslado y asegurar que se cumplen las condiciones del mismo.
- 2.3 Movilizar al paciente dentro de su medio teniendo en cuenta su estado y posición anatómica recomendada.
- 2.4 Ayudar a la deambulación del paciente, asegurando que se cumplen las indicaciones específicas del responsable del plan de cuidados.
- 2.5 Ejecutar las operaciones necesarias para facilitar la correcta exploración y observación del paciente/cliente.
- 2.6 Aplicar tratamientos locales de termoterapia, crioterapia e hidrología médica, siguiendo los protocolos técnicos establecidos e indicaciones de actuación.
- 2.7 Realizar la preparación y administración de medicamentos por vía oral, rectal y tópica.
- 2.8 Realizar cuidados «postmortem» siguiendo los protocolos establecidos.
- 2.9 Distribuir las comidas y apoyar la ingesta en pacientes que así lo requieran.
- 2.10 Colaborar y/o aplicar técnicas de prevención de accidentes y primeros auxilios, siguiendo los protocolos y pautas de actuación establecidos.

Punto tercero: ! !

- 3.1 Realizar la limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental de las distintas consultas/ unidades.
- 3.2 Mantener el orden, limpieza y condiciones higiénicosanitarias de la habitación del enfermo, tanto a nivel hospitalario como domiciliario.
- 3.3 Participar en el control de infecciones nosocomiales.

Punto cuarto: ! !

- 4.1 Detectar las necesidades psicológicas básicas y conductas anómalas en los distintos tipos de pacientes, en su ámbito de competencias.
- 4.2 Prestar apoyo psicológico básico al paciente/cliente para mejorar sus condiciones de vida, en su ámbito de competencias.
- 4.3 Promover actitudes y hábitos de autocuidado de los pacientes/clientes y su participación en asociaciones y grupos de ayuda.
- 4.4 Intervenir, a su nivel, en la formación y promoción de hábitos saludables de alimentación, higiene personal y del medio, y sobre formas de vida en pacientes/clientes, familiares y colectivos.

Punto quinto:

- 5.1 Revelar y archivar radiografías dentales según protocolo técnico y normas de calidad.
- 5.2 Realizar las operaciones de batido, espátulado y mezclado de los materiales requeridos por el facultativo.
- 5.3 Mantener el sillón dental con todos sus elementos y útiles, en perfecto estado de uso.
- 5.4 Realizar la instrumentación operatoria del sillón dental, utilizando «técnica de cuatro y/o seis manos».
- 5.5 Aislar y aspirar el campo operatorio, previo y durante la operatoria dental.
- 5.6 Realizar el acondicionamiento físico y psicológico del paciente que permita su tratamiento dental, antes, durante y posterior a la operatoria, según sus necesidades específicas.

NOTA

Las funciones del primer punto son más propias de la atención primaria y en el ámbito privado. Las de los puntos segundo y tercero están relacionadas principalmente a las actividades prestadas en el ámbito hospitalario. El punto cuarto podría prestarse en ambos ámbitos. El punto quinto hace referencia casi exclusivamente a tareas auxiliares en consultas bucodentales.

2. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES

OBJETIVO

Comprender el concepto de coordinación entre niveles asistenciales dentro del sistema sanitario, su importancia en la continuidad de cuidados y el papel del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en este proceso

INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ SON LOS NIVELES ASISTENCIALES?

Los niveles asistenciales son los distintos **escalones o niveles organizativos en los que se presta atención sanitaria según la complejidad** del problema de salud del paciente.

Niveles: ! !

- **Atención Primaria (AP):** Nivel básico, cercano, continuo y generalista. Primer contacto con el sistema.
- **Atención Especializada (AE):** Segundo nivel. Requiere equipos multidisciplinares, pruebas diagnósticas, hospitalización, etc.

Ejemplo práctico:

Un paciente con hipertensión es controlado por su médico de familia (AP). Si presenta daño renal, se deriva al nefrólogo (AE).

¿QUÉ ES LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES?

La puesta en marcha, progresivamente, de los distintos **programas de salud que han de lograr los objetivos** que se estipulan en el Plan de Atención Sanitaria, pasa por **homologar y homogeneizar a las distintas estructuras asistenciales** de los diferentes niveles para adaptarlas a un fin común. !

En una organización, **los mecanismos de coordinación son los dispositivos de enlace utilizados para potenciar la adaptación mutua entre y dentro de cada uno de los niveles asistenciales**. Los mecanismos de coordinación más comúnmente empleados en los centros sanitarios son los siguientes: !

- **Mecanismos de ajuste mutuo:** la coordinación se consigue mediante la comunicación informal entre el personal de cada una de las organizaciones cuando un trabajo en particular se relaciona con otro.
- **Mecanismos de supervisión directa:** en este caso, un individuo es el que tiene la responsabilidad de coordinar y monitorizar las actividades comunes y convergentes de los niveles asistenciales objeto de su responsabilidad.
- **Estandarización de procesos o de habilidades:** son los procesos más comúnmente impulsados desde la estructura directiva de las organizaciones, se minimizan las variaciones en los procedimientos; se logra mediante la introducción de guías metodológicas de práctica clínica, de formularios de consulta e interrelación ...

La **coordinación entre niveles asistenciales** es el **conjunto de mecanismos y procesos organizativos que permiten la comunicación efectiva y la continuidad asistencial entre los diferentes niveles** (primaria y especializada) **para garantizar una atención integral** al paciente. ! !

Objetivos: Evitar duplicidades, retrasos, errores de información y ofrecer una atención centrada en el paciente. ! !

PRINCIPIOS DE UNA BUENA COORDINACIÓN

- Continuidad de cuidados
- Intercambio fluido de información clínica
- Trabajo en equipo interprofesional
- Uso eficiente de los recursos
- Atención centrada en el paciente

DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

Es un **proceso clínico mediante el cual cada directivo implicado identifica, en conjunto, las metas comunes de la organización, definen las responsabilidades de cada estamento** implicado y lo utilizan como **guía para hacer funcionar cada unidad** y para evaluar el desempeño de cada uno de sus miembros. **!!**

En la implantación y posterior desarrollo de la dirección por objetivos se identifican claramente tres fases:

- Identificación y acuerdo sobre el trabajo que se va a desarrollar.
- Definición de objetivos.
- Evaluación periódica del proceso.

Gracias a la dirección por objetivos **se consigue una mayor implicación de todos los miembros del sistema** en la evolución de este y se logra una gestión de futuro orientada al entorno dirigiendo hacia él los resultados, con iniciativas descentralizadas, participadas por todos, con responsabilidades delegadas y coparticipación en los logros y los fracasos.

EL CONTRATO PROGRAMA

El Contrato Programa es una **herramienta de gestión imperfecta**, pero oportuna, y factible, es pues un **documento suscrito y rubricado entre la dirección del Centro Sanitario (el proveedor) y la dirección gerencia del Servicio de Salud (el contratador)**, generalmente de carácter anual y que se asemeja y simula a un contrato de compra de servicios con una entidad privada. **!!**

El Contrato Programa deberá garantizar el estricto cumplimiento del escenario presupuestario y de los criterios y objetivos establecidos en el mismo.

El Contrato Programa **se va renovando de año en año**, reevaluando el nivel de consecución de los objetivos plasmados a su firma y valorando las posibilidades de crecimiento en la oferta asistencial y de recursos para el siguiente ejercicio. **!**

El **objetivo diana del Contrato Programa es la calidad en la prestación asistencial y la eficiencia en la producción de servicios**, que sólo puede conseguirse si los procesos organizativos de los hospitales y distritos discurren de forma idónea. **!!**

Los **compromisos del Contrato Programa** que se relacionan con la coordinación entre los niveles asistenciales se explicitan en **tres líneas de coordinación: ! !**

A) Coordinación Asistencial

Gracias a la coordinación de los niveles de asistencia y de su homogeneización se podrá conseguir la mejora de la comunicación entre los diferentes niveles de atención (creación de foros para el encuentro, diseño de hojas de interconsulta, confección de protocolos de actuación conjunta, realización de sesiones clínicas ...), y la coordinación en programas especiales (usos racionales de la farmacoterapia, seguimientos domiciliarios del paciente al alta, cuidados de los enfermos en estadios terminales, control de pacientes sometidos a procesos que incrementan de modo cierto y elevado el dolor, seguimiento y cuidados a pacientes con inmunodeficiencia adquirida por VIH, libre elección de especialista y hospital por parte del usuario, revisión y actualización de los distintos protocolos de actuación conjunta).

B) Coordinación en Docencia e Investigación

Gracias a estas medidas de coordinación se logrará permitir la rotación de miembros de los Equipos Básicos de Atención Primaria por los servicios hospitalarios para realizar un reciclaje y una actualización de conocimientos; la puesta en marcha de sesiones clínicas conjuntas, el fomento de las salidas de los especialistas a los centros de salud de forma ordenada y rotacional para descongestionar las consultas externas hospitalarias Y reducir las listas de espera, la formación continuada conjunta de todo el personal, la puesta en marcha de programas de reciclaje conjuntos, la apertura de líneas de investigación que abarquen todos los niveles asistenciales con lo que las muestras serían mayores y las desviaciones típicas se minimizarían.

C) Coordinación en Administración

La virtualidad de este proceso de coordinación se centra en facilitar las políticas de complementariedad entre los niveles y la revisión de programas en relación con el visado de recetas, las coordinaciones en las citas de los especialistas, los acuerdos y convenios sobre financiación y traslados sanitarios, el seguimiento de la evolución de las listas de espera, el control de las expectativas de los usuarios y de su nivel de satisfacción con respecto a la asistencia y cuidados suministrados por el sistema de salud, etc.

NOTA

el Contrato Programa es un instrumento para la obtención de la financiación condicionada, vinculada a un sistema de financiación, el cual tiene como finalidad financiar los esfuerzos orientados a la consecución de unos compromisos.

PLANES DE COLABORACIÓN INTERNIVELES

Estos Planes aúnan las líneas **actitudinales de los tres campos distintos de coordinación: el asistencial, el docente y el administrativo. !**

El Plan Interniveles **es firmado por el Gerente del Área Hospitalaria y los diferentes**

Directores de los centros de la misma, y es remitido a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, y contempla los siguientes compromisos: !

- El Hospital traslada a los Centros de su Área copias de todos los informes de alta hospitalaria que se produzcan.
- Se potencia la Comisión de Coordinación Interniveles para el uso racional del medicamento, que debe aprobar y difundir recomendaciones y protocolos conjuntos de empleo de fármacos.
- El desarrollo de actividades que garanticen la continuidad de los tratamientos y cuidados domiciliarios tras el alta del hospital, elaborando, en el primer momento, protocolos de seguimiento para:
 - Inmovilizados tras cirugía traumatológica y ortopédica.
 - Hernias y eventraciones.
 - Intervenciones proctológicas.
 - Colecistectomías.
 - Intervenciones de varices en miembros inferiores.
 - Intervenciones oncológicas.
 - Pacientes terminales.
 - Accidentes vasculares cerebrales.
- La coordinación entre los dos niveles de asistencia para la integración documental y administrativa.
- Impulsar cuantas actuaciones sean necesarias para mejorar la coordinación con los Servicios Sociales.

CONSIDERACIONES DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN EL SERMAS

Canales habituales: !

- Derivaciones médicas con informes clínicos estructurados
- Historia clínica electrónica compartida (HORUS)
- Comisiones de continuidad asistencial
- Protocolos de alta hospitalaria y seguimiento en AP

Funciones del TCAE:

- Preparación y entrega de informes o documentación clínica
- Apoyo en el alta del paciente: orientación, instrucciones básicas
- Información al paciente y su familia (dentro de sus competencias)
- Colaboración en programas conjuntos de salud (vacunación, crónicos, etc.)
- Apoyo a la enfermería en el seguimiento del paciente en consultas compartidas

EJEMPLOS PRÁCTICOS

- Alta hospitalaria con seguimiento en AP
- Derivación desde AP a hospital para una cirugía
- Paciente crónico en seguimiento conjunto

CONCEPTOS CLAVE:

- **Coordinación** = Comunicación + Continuidad + Cooperación o Coordinación en: **asistencia, docencia e investigación y administración**
- **Historia clínica** compartida: **herramienta fundamental**
- El TCAE es parte del equipo que garantiza la continuidad asistencial
- **Atención centrada en el paciente** → **objetivo común** de todos los niveles

29/12/2025
Este documento fue descargado por Maria del Pilar Marquina desde ucademy.com
Su distribución no está permitida y es solo para uso de alumnos registrados.

3. CONCEPTO DE CUIDADOS, NECESIDADES BÁSICAS Y AUTOCUIDADOS

INTRODUCCIÓN

El TCAE es uno de los dos miembros que conforman la Enfermería, y que, por tanto, mantiene un estrecho contacto con el paciente y su entorno, lo cual le va a convertir en pieza clave no sólo para saber qué le está pasando al paciente sino también para contribuir a su recuperación. Según **Virginia Henderson**: «La Enfermería consiste fundamentalmente en atender al individuo (enfermo o sano) en la realización de las actividades que contribuyen a su salud o a su recuperación (o a una muerte tranquila) y que llevaría a cabo sin ayuda de nadie si tuviera fuerza, voluntad o conocimiento suficiente. Del mismo modo, podemos decir que la contribución de la Enfermería es ayudar al individuo a independizarse de tal asistencia lo más pronto posible».

MODELOS DE ENFERMERÍA

Hay diversas clasificaciones de modelos de enfermería que representan diferentes puntos de vista y explicaciones sobre objetivos a conseguir y plan de cuidados a llevar a cabo.

Remitiéndonos a una de estas clasificaciones, se distinguen **tres tipos de modelos**:

- **Modelos interaccionistas o de relaciones interpersonales !**

Estos modelos están **basados en la interacción enfermerapaciente** y se refieren a todo contacto en el que dos personas ejercen una influencia mutua por medio de la **comunicación (verbal y no verbal)**. Destacan en estos modelos:

- Orlando.
- Travelbee.
- Peplau.

- **Modelos de autocuidados, actividades de la vida diaria y de necesidades personales !**

- **D. Orem**. Modelo de **déficit de autocuidado**. Aquí destaca el concepto de **autocuidado: contribución continua del adulto a su propio ser, salud y bienestar**.
- **V. Henderson**. El modelo de Henderson usa el **concepto de necesidades** sobre las que se conforman los **cuidados de enfermería**.
- **Nancy Roper, Loga y Tierny**. La filosofía de estas autoras se **basa en que la salud de las personas y las enfermedades que padecen van unidas a su estilo de vida**. Se propone la **enfermería individualizada** en cuanto a la persona se refiere, cambiando solo algún estilo de vida negativo.

- **Modelos de sistemas !**

Están **basados en la teoría general de sistemas**. Se contempla al **paciente como un sistema abierto y se define el sistema como un conjunto de partes relacionadas** que funcionan juntas para formar un todo. Aquí destaca:

- **D. Johnson y Callista Roy**.

MODELO DE ENFERMERÍA DE VIRGINIA HENDERSON. TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS !!

Es la **figura más representativa del modelo de suplencia o ayuda. !**

La teoría de Henderson **se basa** en el «concepto de las necesidades básicas humanas». Parte del principio de que todos los seres humanos tienen una serie de necesidades básicas que se deben satisfacer (fisiológicas, psicológicas o sociales), y que son normalmente cubiertas por cada individuo cuando está sano y tiene suficientes conocimientos para ello. Cuando el individuo no puede satisfacerlas por sí mismo se provoca una situación negativa de salud. !

Su **concepción de la enfermería es funcional**, ya que considera que la única función de la enfermera es la de ayudar a la persona enferma o sana en todas las actividades o tareas que favorezcan la salud, la recuperación o incluso la muerte tranquila en el caso de enfermos terminales. !

Equipara salud con independencia. “La calidad de la salud, más que la vida en sí misma, es la reserva de energía mental y física que permite a la persona trabajar de la forma más efectiva y alcanzar su mayor nivel potencial de satisfacción en la vida”. !

Establece los componentes que caracterizan la asistencia de enfermería. Identifica catorce necesidades básicas, que se corresponden con las necesidades del paciente.

NOTA

Clasificación más utilizada: Virginia Henderson – 14 necesidades

1. Respirar normalmente
2. Comer y beber adecuadamente
3. Eliminar los desechos del organismo
4. Moverse y mantener posturas adecuadas
5. Dormir y descansar
6. Escoger ropa adecuada: vestirse y desvestirse
7. Mantener la temperatura corporal
8. Mantener la higiene y el cuidado de la piel
9. Evitar peligros ambientales
10. Comunicarse
11. Vivir según creencias y valores
12. Trabajar y sentirse realizado
13. Participar en actividades recreativas
14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad

Respecto a la **relación enfermerapaciente**, establece **tres niveles diferenciados**:

- **Enfermera como un sustituto** de algo necesario para el paciente ya que, de forma temporal, sustituye la falta de fuerza física, psicológica, y la ausencia de conocimientos del paciente.

- **Enfermera como ayuda** para el paciente, ya que colabora con él ayudándole a recuperar su independencia.
- **Enfermera como compañera** del paciente, ya que ambos deben colaborar estrechamente en el tratamiento.

MODELO DE ENFERMERÍA DE DOROTHEA OREM. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO !!

Estableció la teoría del **autocuidado**. En ella se explica y describe el autocuidado. Lo define como «**una actividad aprendida por la persona y orientada hacia un objetivo**». Es, por tanto, una **conducta ante la vida dirigida hacia uno mismo en beneficio de la salud y el bienestar**. !

Considera al **paciente como una unidad** que se puede contemplar desde un punto de vista biológico, social y simbólico, llevando a cabo **acciones de autocuidado sobre su conducta** con el fin de mantener su vida, salud y bienestar. !

Contempla la **función de enfermería como el hecho de facilitar atención** para **influir** de alguna forma **sobre el paciente** con el fin de que este evolucione **y llegue a conseguir un óptimo nivel de autocuidado**. !

NOTA

Requisitos universales del autocuidado

- Mantenimiento de un ingreso suficiente de aire.
- Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua.
- Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos.
- Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal.
- Equilibrio entre actividades y descanso.
- Equilibrio entre soledad y la comunicación social.
- Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano.
- Proporción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano.

Existen varias **clases de autocuidados**: los que se derivan de las **necesidades básicas del individuo o requisitos universales** (alimento, descanso, oxígeno...), los asociados al proceso de desarrollo o **requisitos de desarrollo** (niñez, embarazo, vejez...) y los derivados de las desviaciones del estado de salud o **requisitos de desviación de la salud**. !!

- **Teoría del déficit del autocuidado**. Describe y explica las razones por las que la enfermería puede ayudar a las personas. El déficit de autocuidado se da cuando la demanda de acción es mayor que la capacidad de la persona para actuar, incapacitándola para el autocuidado continuo. La existencia de un déficit de autocuidado es la condición que avala la necesidad de los cuidados de enfermería.
- **Teoría de los sistemas de enfermería**. Describe y explica las relaciones que es necesario establecer para que se dé la enfermería. Un sistema de enfermería es «un complejo método de acciones realizadas por las enfermeras determinadas por las demandas de autocuidado terapéutico del paciente».

Orem **identifica tres sistemas de enfermería** que son: **!!**

1. **Sistema de enfermería totalmente compensador**: trata de compensar una incapacidad total del paciente para su autocuidado. Las actividades manipulativas y de deambulaci3n las realiza en su totalidad la enfermera. En este sistema, la enfermería se encarga del cuidado terapéutico y compensa con sus actuaciones la incapacidad del paciente para realizar su propio autocuidado a la vez que le apoya y le protege.
2. **Sistema de enfermería parcialmente compensador**: enfermera y paciente realizan medidas de asistencia y otras actividades manipulativas o de deambulaci3n. En este caso, la enfermera realiza algunas de las acciones de autocuidado del paciente, tratando de compensar sus limitaciones. Por su parte, el paciente realiza también algunas acciones de su autocuidado, dependiendo de sus destrezas y capacidades físicas y psíquicas.
3. **Sistema de apoyo educativo**: dirigido a pacientes que son capaces o deben aprender a realizar acciones propias de su autocuidado y que, en principio, no pueden hacerlo sin la correspondiente ayuda. La enferma orienta a la persona para llevar a cabo las acciones de autocuidado necesarias.

Estableci3 **cinco métodos de ayuda**: **!!**

1. Actuar o hacer por.
2. Guiar.
3. Enseñar.
4. Apoyar.
5. Proporcionar un entorno que estimule al desarrollo.

RESUMEN Y CONSIDERACIONES GENERALES

CONCEPTO DE CUIDADOS

Los cuidados son el **conjunto de acciones destinadas a mantener, recuperar o mejorar la salud y el bienestar** de una persona, **atendiendo sus necesidades** físicas, emocionales, sociales y espirituales. **!!**

- Los cuidados se entienden como un conjunto de actividades y estrategias que buscan proteger y promover la salud y el bienestar de las personas en diferentes contextos.
- Estos cuidados **pueden ser brindados por profesionales** de la salud, **cuidadores familiares o por la propia persona** a través del autocuidado.
- Los cuidados **abarcen desde la atención primaria hasta la atención especializada**, incluyendo la **prevención**, el **tratamiento** y la **rehabilitaci3n**.
- Un concepto clave es que los cuidados son un derecho humano y una responsabilidad compartida entre individuos, familias, comunidades y sistemas de salud

En el entorno sanitario:

Son **actividades sistematizadas y dirigidas a preservar la salud** del paciente, realizadas por profesionales sanitarios como médicos, enfermeras y TCAE.

Papel del TCAE:

El TCAE realiza cuidados auxiliares que se enmarcan en la atención básica al paciente, como:

- Higiene
- Movilización
- Alimentación
- Apoyo emocional
- Observación de signos y síntomas

NECESIDADES BÁSICAS

Son **condiciones fundamentales que todas las personas necesitan** cubrir para vivir de forma saludable y digna. **!**

- Las necesidades básicas son los **requerimientos indispensables para la vida** y el desarrollo humano, como comer, dormir, respirar, moverse, etc.
- La satisfacción de estas necesidades es **fundamental para mantener la salud y prevenir** enfermedades.
- Estas necesidades pueden ser **satisfechas por la propia persona** a través del autocuidado **o con la ayuda de otras** personas, como cuidadores o profesionales de la salud.

Importancia para el TCAE:

El TCAE ayuda a identificar y cubrir estas necesidades cuando el paciente no puede hacerlo por sí mismo, favoreciendo así su autonomía y recuperación.

CONCEPTO DE AUTOCUIDADO

El autocuidado es la **capacidad que tiene una persona para cuidarse a sí misma, satisfaciendo sus necesidades básicas** de forma autónoma. **!!**

- Capacidad de las personas para realizar acciones que promuevan su propia salud y bienestar.
- Implica la **gestión de la propia salud**, incluyendo la **prevención** de enfermedades, la **gestión** de enfermedades crónicas y la **toma de decisiones** informadas sobre la salud.
- Es **esencial para el mantenimiento de la autonomía** y la independencia de las personas, así como para la promoción de una **vida activa y saludable**.
- El fomento del autocuidado es un **objetivo importante en la atención de la salud**, ya que permite a las personas tomar un papel más activo en el cuidado de su propia salud.

Tipos de autocuidado:

- Autocuidado total → persona autónoma
- Autocuidado parcial → requiere ayuda (TCAE interviene)
- Déficit total de autocuidado → el paciente depende totalmente

Objetivo del sistema sanitario:

- Promover el autocuidado en los pacientes.
- Educar, reforzar y apoyar hasta lograr el mayor grado posible de independencia.

4. EL HOSPITAL Y LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y DE ADAPTACIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO

EL HOSPITAL COMO ENTORNO SANITARIO

El hospital es un centro sanitario especializado en prestar atención médica y de enfermería a pacientes con procesos agudos, crónicos o que requieren intervención diagnóstica o quirúrgica.

Desde el punto de vista del paciente: !!

El hospital no es solo un lugar de atención médica: representa un **entorno desconocido, impersonal** y muchas veces **amenazante**, donde **se pierden rutinas, autonomía y contacto con el entorno habitual**. Se producen una serie de **cambios emocionales** como: estrés, temor, miedo, depresión y en muchos casos, agresión.

IMPACTO DE LA HOSPITALIZACIÓN EN EL PACIENTE

La hospitalización es una **situación de crisis que puede alterar el equilibrio** físico, psicológico y social del paciente.

A nivel psicológico: !!

- **Ansiedad y miedo**: a la enfermedad, al dolor, a los procedimientos, al pronóstico.
- **Depresión**: especialmente en estancias prolongadas o en pacientes con enfermedades crónicas.
- Sentimientos de **aislamiento o soledad**.
- **Alteraciones del sueño y del estado de ánimo**.
- **Desorientación** (en ancianos, frecuente el síndrome confusional agudo o "delirium").

A nivel social: !!

- **Separación** del entorno familiar y laboral.
- **Pérdida del rol** social o profesional.
- **Dependencia** de otras personas para actividades básicas.

A nivel personal: !!

- Pérdida de la **intimidad**.
- Cambio en la **imagen** corporal.
- Pérdida de **autonomía** (higiene, alimentación, movilidad).

NOTA

Para **Rodríguez Marín**, las consecuencias del ingreso de un enfermo en el hospital son las siguientes:

- Extrañamiento por inserción en un medio desconocido con pautas culturales diferentes.
- Situación de ignorancia por desconocimiento de los procesos que han de tener lugar y del lenguaje propio del nuevo entorno. Esta ignorancia se suma a la ya existente respecto de la enfermedad.

- Exigencias de adaptación tanto al entorno físico como psicosocial, y la necesidad de un cambio de hábitos comportamentales personales.
- Pérdida de la intimidad y de la privacidad.
- Pérdida del control de sus actividades cotidianas y de las decisiones habituales. Pone su vida en manos de los demás sobre la base de una confianza que, al principio, solo se apoya en el reconocimiento social de la pericia médica profesional.
- Devaluación de la persona. El paciente se ve convertido en un caso más, en un número. Pérdida de independencia y pase a una situación de dependencia.
- Modificación del papel de enfermo que hasta entonces asumía al modificarse la interacción médicoenfermo. Interrupción en el desempeño de los roles normales.
- Separación brusca del marco social habitual, especialmente de la familia Y del trabajo.
- Pérdida del apoyo social al menos a nivel parcial.

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN

Existen **mecanismos corporales y mentales que permiten enfrentarse a las amenazas de peligros reales o imaginarios: reacción de fugalucha** (respuesta fisiológica que prepara el sujeto a enfrentarse a su temor al separarse de la causa a o no ceder terreno y luchar).

También tenemos los denominados **mecanismos de defensa, llamados «mecanismos mentales»: ! !**

- **Racionalización:** por la que el sujeto propone motivos socialmente aceptables de su conducta.
- **Desplazamiento:** los sentimientos agresivos no se dirigen contra la persona u objeto ofensivo, sino a un sustituto. Dentro de este mecanismo tenemos la llamada «utilización de un objeto receptor de desplazamientos» como familia, amigos, pareja, etc.
- **Proyección:** a menudo atribuimos nuestros sentimientos o actitudes inaceptables a los demás. Son sentimientos que no se quieren admitir, de este modo protegemos nuestros sentimientos de autovalía.
- **Identificación:** cuando las personas no pueden lograr sus propios objetivos, tal vez se identifiquen con otro sujeto que sí lo ha hecho. Hacen suyas las características de este sujeto, encontrándose muy apenados si se ataca a su ídolo. Este mecanismo de defensa, si no se utiliza de forma extrema, a menudo es de utilidad para lograr un objetivo.
- **Compensación:** puede ser como el anterior, constructivo. Por medio de este proceso tratamos de suplir deficiencias reales o imaginarias al convencernos de que somos muy capaces en un campo de actividad diferente, en el que consideramos que somos deficientes o, a veces, en el mismo campo de actividad.
- **Negación:** negamos el motivo o problema inaceptable y, de forma inconsciente, rehusamos aceptar que existe. La primera reacción del sujeto, al saber que sufre un problema de salud grave, posiblemente consista en negar que las palabras que escucha son verdaderas. Así pues, tal vez diga que no sufre ninguna enfermedad, que no es posible y que el laboratorio, médico o cualquier prueba diagnóstica confundió sus resultados con los de otra persona. A veces la negación perdura durante largo tiempo, y es muy importante que la persona acepte el diagnóstico antes de someterse al tratamiento.

- **Regresión:** los sujetos, cuando se encuentran enfermos, a menudo se ven obligados a sacrificar su independencia en lo que se refiere a cuidar de sí mismos; al verse obligados a aceptar que otra persona haga lo que ellos solían hacer, como alimentarse o asearse, lo consideran como una forma de regresión a una fase anterior de dependencia.

NOTA

El temor a «lo desconocido» es una de las causas principales que originan ansiedad en los que acuden a un hospital. Esto valida la idea de **Kalish** de que «la **necesidad de conocimiento**» es la **segunda necesidad básica más importante**, según se pone de manifiesto por la curiosidad.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADAPTACIÓN

FACTORES DEL PACIENTE	FACTORES DEL ENTORNO HOSPITALARIO
Edad	Ruido y falta de intimidad
Personalidad	Profesionales desconocidos
Apoyo familiar	Rutinas rígidas y falta de control
Gravedad de la enfermedad	Ingresos prolongados
Experiencias previas	Pérdida de referencia temporal

Para **Buckman**, lo importante es **clasificar las reacciones como de adaptación**, si ayudan al enfermo a resolver el problema, **o de inadaptación**, si por el contrario agravan la situación.

Desde esta perspectiva se pueden clasificar así:

ADAPTACIÓN	INADAPTACIÓN
Humor	Culpabilidad
Miedo	Angustia
Realizar una ambición	Peticiones imposibles
Negación	Negación patológica
Cólera difusa	Cólera contra personas
Esperanza realista	Esperanza quimérica
Deseo sexual	Rabia prolongada
Llanto	Crisis de llanto violentas
Regateo	Manipulación

Las **respuestas de adaptación**, según **Coe**, pueden ser de **cuatro tipos**: !!

- La **regresión o retirada**: el paciente intenta escapar del hospital, pero como su movilidad está controlada, la retirada es sobre todo psicológica.
- La **agresión**: el paciente lleva a cabo una resistencia abierta a las reglas.
- La **integración**: cuando el paciente acata la mayoría de las reglas del hospital y se torna un miembro activo de la subcultura hospitalaria. Requiere interacción social con otros pacientes, para lo cual hace falta una hospitalización prolongada. Puede incluso que no quiera abandonar el hospital al alta.
- La **aquiescencia**: asume la rutina del hospital mientras se evalúa su situación. Está tan impactado, que permanece pasivo y cumple las demandas impuestas.

RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO

Rodríguez y Zurriaga consideran de mayor interés las siguientes respuestas de afrontamiento: !!

- **Búsqueda de instalación o mantenimiento de la sensación de control**
- **Respuestas de acción directa**. Son acciones sobre el entorno para cambiar la situación. Se engloban aquí el control instrumental (comportamental) y el control decisional.
- **Negación**.
- **Evitación**. Es una forma de negación. Una forma extrema de evitación es el suicidio.
- **Resignación o aceptación de la enfermedad**.
- **Reinterpretación positiva**. Se trata de buscar el significado de la enfermedad y reinterpretar nuestra vida en función de ello.
- **Cambios de vida positivos**. Es la acción directa de la reinterpretación positiva
- **Uso de imaginación mental**.
- **Conductas confrontativas**. Acciones más o menos directas que intentan cambiar la situación. Dentro de este tipo de conductas está la expresión de las emociones positivas y negativas.
- **Adopción del papel de enfermo**. Es positiva o negativa dependiendo de si se correlaciona la gravedad de la enfermedad con el papel que asume el enfermo.

VALORACIÓN ENFERMERA SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO DEL PACIENTE

- Humor
- Tensión (en el contexto mental)
- Actividad motora
- Nivel de consciencia
- Comunicación verbal
- Alimentación
- Ritmo del sueño
- Vestimenta
- Memoria
- Relaciones con los demás
- Respuesta al tratamiento

PAPEL DEL TCAE EN LA ADAPTACIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO

El TCAE, como profesional asistencial de contacto directo, desempeña un papel crucial en el apoyo psicosocial del paciente hospitalizado.

Objetivos del TCAE:

- Favorecer la **adaptación emocional** del paciente.
- Prestar una **atención humanizada y empática**.
- Colaborar con enfermería para **identificar signos de desajuste** psicosocial.

Funciones concretas del TCAE:

ÁMBITO	INTERVENCIÓN
Comunicación	Escucha activa, conversación calmada, transmitir confianza
Apoyo emocional	Mostrar cercanía, respeto, comprensión
Observación	Detectar signos de ansiedad, llanto, desorientación, agresividad
Información básica	Orientar sobre rutinas, horarios, procedimientos sencillos
Favorecer rutinas	Respetar horarios de descanso y comida, permitir objetos personales
Privacidad e intimidad	Tapar al paciente, cuidar espacios personales
Estimulación del autocuidado	Fomentar que el paciente participe en su aseo, alimentación, etc.
Apoyo familiar	Facilitar la presencia de familiares, explicar normas básicas

TIPOS DE PACIENTES CON MÁS RIESGO DE DESAJUSTE !!

- **Personas mayores:** riesgo de delirium, pérdida funcional rápida.
- **Niños:** ansiedad por separación, miedo al dolor.
- Pacientes con **enfermedades mentales:** desorientación, brotes psicóticos.
- Pacientes **críticos** o con **estancia prolongada**.
- Pacientes **inmigrantes** o con barreras idiomáticas.

GUÍAS Y PROTOCOLOS RELACIONADOS (SERMAS)

Las guías del SERMAS promueven:

- **Atención centrada en la persona** y su entorno psicosocial.
- Apoyo emocional y **humanización** del cuidado.
- **Prevención de deterioro emocional** durante la hospitalización.
- Intervención del **equipo interdisciplinar** (enfermería, trabajo social, psicología, TCAE).

NOTA

Se impulsa el modelo de humanización de la asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (**Plan de Humanización**). !!

CONCEPTOS CLAVE

- **Hospitalización** = **Situación de crisis** para el paciente.
- **Impacto**: físico, psicológico, emocional y social.
- TCAE = primer contacto humano → apoyo emocional, observación, cercanía.
- **Humanización** del cuidado = **objetivo transversal en el SERMAS**.
- Adaptación = proceso dinámico influido por múltiples factores.

Este documento fue descargado por María del Pilar Marquina des...
Su distribución no está permitida y es solo para uso de alumnos registrados
29/12/2025



Este documento fue descargado por [nombre] el 20/05/2025
Su distribución no está permitida sin el consentimiento de la Universidad Marquina desde ucademy.com
para uso de alumnos registrados.